# Sağlıkta Eşitsizlikler

*Kaynaklar: "Sağlıkta Eşitsizlikler" ders sunumu (PAÜ Tıp Fakültesi) ve sunumun dayandığı kaynaklar (Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Öztek 2020, Aba ve Ateş 2015). Bu konudan 2022-2023, 2023-2024, 2024 ve 2025-2026 sınavlarında soru sorulmamıştır.*

## Bu kitap nasıl okunmalı?

Bu kitap serinin diğerlerinden iki noktada ayrılır. Birincisi, konu bir hastalık değil, hastalıkların toplum içinde nasıl dağıldığıdır: aynı KOAH, aynı astım, aynı tüberküloz yoksul, eğitimsiz ve kırsalda yaşayan insanlarda daha sık görülür, daha geç tanınır ve daha kötü seyreder. Bu farkların ne kadarının kaçınılabilir ve adaletsiz olduğunu ve nasıl ölçülüp azaltılabileceğini anlatır. İkincisi, **son dört sınavda bu konudan soru gelmemiştir**. Zamanınız kısıtlıysa bu kitabı serinin sonunda okuyun.

Konu sınavda sorulursa soru büyük olasılıkla bir tanıma, bir listeye ya da bir sayıya dayanır. Bu yüzden kitapta ezber gerektiren listeler (2008 DSÖ raporunun beş temel sorunu, eşitsizliklerle mücadelenin üç ilkesi, İnsani Gelişme Endeksi'nin bileşenleri, HEAT'in beş eşitsizlik boyutu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) tablolar hâlinde verilmiştir. Bu listelerin nedenini anlatan metin ise onları hatırlamayı kolaylaştırır. Bölüm sonlarında çıkmış soru olmadığı için konuyu pekiştiren yeni sorular vardır.

Sunumdaki sayısal veriler ilgili bölümlerde grafiklere dönüştürülmüştür. Türkiye'deki eşitsizliklerin boyutunu gösteren iki grafik (Şekil 5.1 ve 5.2), sunumun belki de en öğretici kısmıdır.

## İçindekiler

**1. Temel Kavramlar: Sağlık, Eşitlik ve Hakkaniyet**

DSÖ'nün sağlık tanımı · eşitlik ve hakkaniyet · kaçınılabilir ve adaletsiz farklar · sağlıkta eşitliğin tanımı · ters bakım yasası

**2. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri**

Beş belirleyici alan · Dahlgren ve Whitehead modeli · Black Raporu · sosyal gradyan · belirleyicilerin hastalığa dönüşmesi

**3. Tarihsel Süreç ve Uluslararası Belgeler**

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi · Alma-Ata · 2008 DSÖ raporu ve beş temel sorun · Bin Yıl ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri · Astana Bildirgesi

**4. Rakamlarla Küresel Eşitsizlik**

Sağlıkla ilgili SKH 3 hedefleri: anne ve çocuk ölümleri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, üreme sağlığı, çevre, tütün, aşılar, sağlık iş gücü · DSÖ'nün on gerçeği

### 5. Eşitsizliğin Ölçülmesi, Türkiye ve Mücadele

İnsani Gelişme Endeksi · mutlak ve göreli ölçüler · Health Equity Monitor ve HEAT · Türkiye verileri · pandemi · mücadelenin üç ilkesi · hekimin görevleri

## Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı




*Kitap 6'ya giren soru sayısı: dört sınavın hiçbirinde bu konudan soru yoktur. Bu yüzden bölüm sonlarında yalnızca konuyu pekiştirmek için hazırlanmış yeni sorular bulunur.*

BÖLÜM 1 · KAVRAMLAR

# Temel Kavramlar: Sağlık, Eşitlik ve Hakkaniyet

*"Sağlıkta eşitsizlik" ifadesi Türkçede iki ayrı kavram için kullanılır: iki grup arasında ölçülen herhangi bir fark ve bu farklardan adaletsiz olanları. İngilizcede bu iki kavramın ayrı adları vardır: inequality ve inequity. Bu bölüm, konunun bütün geri kalanının dayandığı bu ayrımı ve sağlık kavramının kendisini anlatır. Ayrımın pratik önemi büyüktür: her farkı düzeltmeye çalışmak mümkün değildir, ama adaletsiz farklar politikayla azaltılabilir.*

## 1.1. Sağlık nedir?

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası (1946'da imzalandı, 1948'de yürürlüğe girdi) sağlığı şöyle tanımlar: **"Sağlık, yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir."** Sunum tanımın üç boyutunu vurgular: **beden, ruh, sosyal**.

Bu tanımın eşitsizlik konusu açısından en önemli kelimesi "sosyal"dır. Sağlık yalnızca bedensel bir durum olsaydı, insanların gelirleri, eğitimleri ya da yaşadıkları yer sağlık sorununun dışında kalırdı. Tanım sosyal iyilik hâlini sağlığın parçası saydığı için, insanların sosyal koşulları arasındaki farklar da doğrudan sağlık konusudur. Aynı anayasa bir adım daha atar: ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmak, ırk, din, siyasi inanç, ekonomik ya da sosyal durum ayrımı yapılmaksızın **her insanın temel haklarından biridir**. Sağlık bir hak olarak tanımlandığında, ona ulaşmadaki adaletsiz farklar da bir hak ihlali olarak görülür.

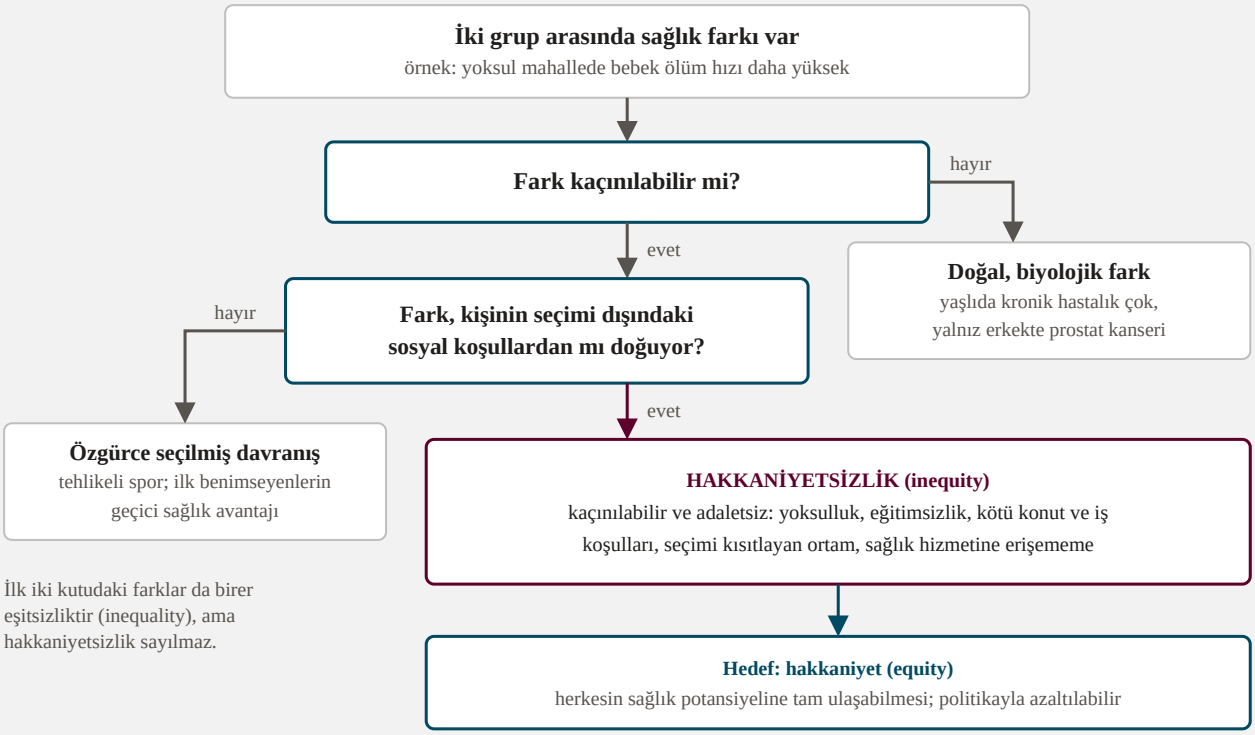
## 1.2. Eşitlik ve hakkaniyet

Sunum, Aba ve Ateş'e dayanarak iki kavram çiftini ayırır:

| Kavram | Anlamı | Niteliği |
|---|---|---|
| **Equality** = eşitlik<br>**Inequality** = eşit olmama durumu | Gruplar arasında ölçülen fark | Betimleyicidir: bir sayıdır, değer yargısı içermez |
| **Equity** = hakkaniyet, adalet, haklılık, doğruluk<br>**Inequity** = hakkaniyetsiz, adil olmayan | Farkın adil olup olmadığı | Değerlendiricidir: bir yargı içerir |

Her inequity bir inequality'dir, ama her inequality bir inequity değildir. Yaşlıların gençlerden daha çok kronik hastalığı vardır. Prostat kanseri yalnızca erkeklerde görülür. Bunlar ölçülebilir farklardır, ama kimse bunları adaletsiz saymaz. Yoksul mahallelerde bebek ölüm hızının zengin mahallelerin üç katı olması ise hem ölçülebilir bir farktır hem de adaletsizdir, çünkü bu bebeklerin biyolojisinde değil yaşam koşullarında bir fark vardır. DSÖ'nün sunumda yer alan tanımı bu ayrımı tek cümlede verir: **eşitsizlik (inequity), haksızlık ve adaletsizlik yönü olan, kaçınılabilir farklılıklardır**.

Bir farkın adaletsiz olup olmadığına karar vermek için iki soru sorulur (Şekil 1.1): fark kaçınılabilir mi ve kişinin kendi seçimi dışındaki sosyal koşullardan mı doğuyor? Bu iki soru, Margaret Whitehead'in 1990'da DSÖ Avrupa Bölgesi için yaptığı ve bugün de kullanılan sınıflamadan gelir. Whitehead sağlık farklarının yedi kaynağını sayar ve bunların üçünü kaçınılmaz ya da adil, dördünü kaçınılabilir ve adaletsiz kabul eder:




*Şekil 1.1 — Bir sağlık farkı ne zaman hakkaniyetsizliktir? Kaçınılamayan biyolojik farklar ve özgürce seçilmiş davranışlardan doğan farklar birer eşitsizliktir (inequality), ama adaletsiz sayılmaz. Kaçınılabilir olan ve kişinin seçimi dışındaki sosyal koşullardan doğan farklar hakkaniyetsizliktir (inequity). Politikanın hedefi bunlardır.*

| Kaçınılmaz ya da adil sayılan farklar | Kaçınılabilir ve adaletsiz farklar |
|---|---|
| 1. Doğal, biyolojik farklılık (yaş, cinsiyet, kalıtım)<br>2. Özgürce seçilmiş, sağlığa zararlı davranış (tehlikeli sporlar)<br>3. Sağlığı geliştiren bir davranışı ilk benimseyen grubun geçici avantajı (diğer gruplar kolayca yetişebiliyorsa) | 4. Seçimi sosyoekonomik koşullarla kısıtlanmış, sağlığa zararlı davranış (ucuz ve sağlıksız beslenmek zorunda kalmak)<br>5. Sağlıksız yaşam ve çalışma koşullarına maruz kalma (tozlu iş yeri, rutubetli ev, biyokütle dumanı)<br>6. Temel sağlık hizmetlerine ve diğer kamu hizmetlerine yetersiz erişim<br>7. Hastalığa bağlı sosyal hareketlilik: hasta olan kişinin işini kaybedip daha alt bir sosyal konuma düşmesi |

Eşitlik ile hakkaniyet arasındaki farkı göstermek için sıkça kullanılan bir benzetme vardır: boyları farklı üç kişi bir duvarın arkasındaki maçı izlemek ister. **Eşitlik** herkese aynı yükseklikte birer kutu vermektir. Uzun boylu kişinin kutuya ihtiyacı yoktur, kısa boylu kişi ise kutuyla bile maçı göremez. **Hakkaniyet** kutuları ihtiyaca göre dağıtmaktır: herkesin aynı sonuca, yani maçı görmeye ulaşması hedeflenir. Sağlık hizmetinde de amaç herkese aynı miktarda hizmet vermek değil, herkesin sağlık potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır.

## 1.3. Sağlıkta eşitlik nedir?

Sunum iki tanım verir. Birincisi hizmete erişime odaklanır: **yasal düzenlemelere bağlı kalarak, kaliteli ve etkili şekilde sunulan sağlık hizmetine bireylerin ihtiyaç duydukları anda adil bir şekilde erişebilmelerine engel olan, dezavantaj yaratan durumların ortadan kaldırılması "sağlıkta eşitlik" olarak tanımlanabilir**. İkincisi DSÖ'nündür ve sonuca odaklanır: **sağlıkta eşitlik, herkes sağlık ve esenlik için tam potansiyeline ulaştığında elde edilir**.

Sunum eşitsizliğin nasıl fark edileceğine dair iki ölçüt de verir:

- **Farklı sosyal gruplar arasında hizmetlerin kullanım oranları arasında fark varsa, bu farkı yaratan nedenlerin bulunması gerekir.** Farkın kendisi bir uyarıdır. Neden ihtiyaç farkı ise (örneğin yaşlılar daha çok hastaneye başvurur) adildir. Neden erişim engeli ise (ulaşım, ücret, dil, bilgi) adaletsizdir.
- **Irk, etnik köken gibi nedenlerden dolayı dezavantajlı bir grup diğer gruplara göre daha gecikmeli sağlık hizmeti alıyorsa eşitsizlik ortaya çıkar.** Örneğin aynı göğüs ağrısıyla başvuran iki hastadan biri dil engeli nedeniyle daha geç değerlendiriliyorsa bu bir hakkaniyetsizliktir.

Hizmet sunumunda hakkaniyet iki yönlüdür. **Yatay hakkaniyet:** aynı ihtiyaca aynı hizmet. Aynı astım ağırlığındaki iki çocuk, aileleri farklı gelir düzeyinde de olsa aynı inhaler tedaviyi almalıdır. **Dikey hakkaniyet:** farklı ihtiyaca farklı hizmet. İhtiyacı daha büyük olana daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Örneğin bebek ölüm hızı yüksek bir bölgeye daha çok ebe ve hemşire gönderilmelidir.

***Ters bakım yasası***

Gerçekte sağlık hizmeti çoğu zaman dikey hakkaniyetin tersine dağılır. İngiliz aile hekimi Julian Tudor Hart 1971'de bunu "ters bakım yasası" (inverse care law) olarak adlandırdı: **iyi tıbbi bakıma ulaşılabilirlik, hizmet verilen toplumun ihtiyacıyla ters orantılıdır**. Hastalığın en sık olduğu yoksul bölgelerde hekim sayısı en azdır, hekimler en yorgundur ve hizmet en kısadır. Piyasa koşullarına bırakılan hizmet bu yasaya daha güçlü uyar. 2008 DSÖ raporundaki "tersine hizmet" sorunu bu yasanın küresel ölçekteki karşılığıdır (Bölüm 3.4).

# Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU 1 (YENİ)

**Aşağıdaki sağlık farklarından hangisi bir hakkaniyetsizlik (inequity) örneğidir?**

A) 70 yaş üstünde kronik hastalık sıklığının gençlerden yüksek olması · B) Prostat kanserinin yalnızca erkeklerde görülmesi · C) Yoksul ve kırsal bölgelerde annelerin daha az doğum öncesi bakım ziyareti alması · D) Dağcılık yapanlarda yaralanmaların daha sık olması · E) Kadınlarda meme kanserinin erkeklerden çok daha sık görülmesi

**Doğru: C.** Doğum öncesi bakıma erişimdeki fark kaçınılabilirdir ve annenin seçimi dışındaki sosyal koşullardan (gelir, ulaşım, eğitim) kaynaklanır. Hem kaçınılabilir hem adaletsiz olduğu için hakkaniyetsizliktir.

A, B ve E doğal, biyolojik farklardır (yaş ve cinsiyet). D özgürce seçilmiş bir davranışın sonucudur. Dördü de ölçülebilir birer eşitsizliktir (inequality), ama adaletsiz sayılmaz.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 2 (YENİ)

**Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında yer alan boyutlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?**

A) Bedensel ve ruhsal · B) Bedensel, ruhsal ve sosyal · C) Bedensel, ruhsal ve ekonomik · D) Bedensel ve sosyal · E) Ruhsal, sosyal ve çevresel

**Doğru: B.** DSÖ Anayasası'na göre sağlık, yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir.

Diğer şıklar bu üç boyuttan birini eksik bırakır ya da tanımda yer almayan bir boyut (ekonomik, çevresel) ekler. Ekonomik ve çevresel koşullar sağlığın belirleyicileridir, tanımın boyutları değildir (Bölüm 2).

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 3 (YENİ)

**"İyi tıbbi bakıma ulaşılabilirlik, hizmet verilen toplumun ihtiyacıyla ters orantılıdır" ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Yatay hakkaniyet · B) Dikey hakkaniyet · C) Ters bakım yasası · D) Sosyal gradyan · E) Evrensel sağlık kapsamı

**Doğru: C.** Julian Tudor Hart'ın 1971'de tanımladığı ters bakım yasasıdır: ihtiyacın en büyük olduğu yerde hizmet en azdır.

A (aynı ihtiyaca aynı hizmet) ve B (farklı ihtiyaca farklı hizmet) hakkaniyetin iki ilkesidir. Ters bakım yasası dikey hakkaniyetin çiğnendiğini anlatır. D, sağlığın sosyal konum düştükçe basamak basamak kötüleşmesidir (Bölüm 2.4). E, herkesin ihtiyaç duyduğu hizmeti maddi sıkıntıya düşmeden alabilmesidir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

# Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

*Bir insanın ne kadar sağlıklı yaşayacağını belirleyen etkenlerin küçük bir kısmı hastanede, büyük kısmı ise evde, okulda, iş yerinde ve sokakta şekillenir. Tahminlere göre tıbbi bakım, toplumların sağlık sonuçlarındaki değiştirilebilir farkın yalnızca yaklaşık %10-20'sini açıklar. Geri kalanı davranışlar, çevre ve sosyoekonomik koşullardır. DSÖ bu koşulları sağlığın sosyal belirleyicileri olarak adlandırır: insanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı koşullar ve bu koşulları biçimlendiren güç, para ve kaynak dağılımı. Bu bölüm belirleyicileri iki modelle düzenler ve eşitsizliğin bilimsel olarak nasıl kanıtlandığını anlatır.*

## 2.1. Beş belirleyici alan

Sunumdaki ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çerçevesi sosyal belirleyicileri beş alanda toplar. Her alanın sağlığı nasıl etkilediği somut örneklerle anlaşılır:

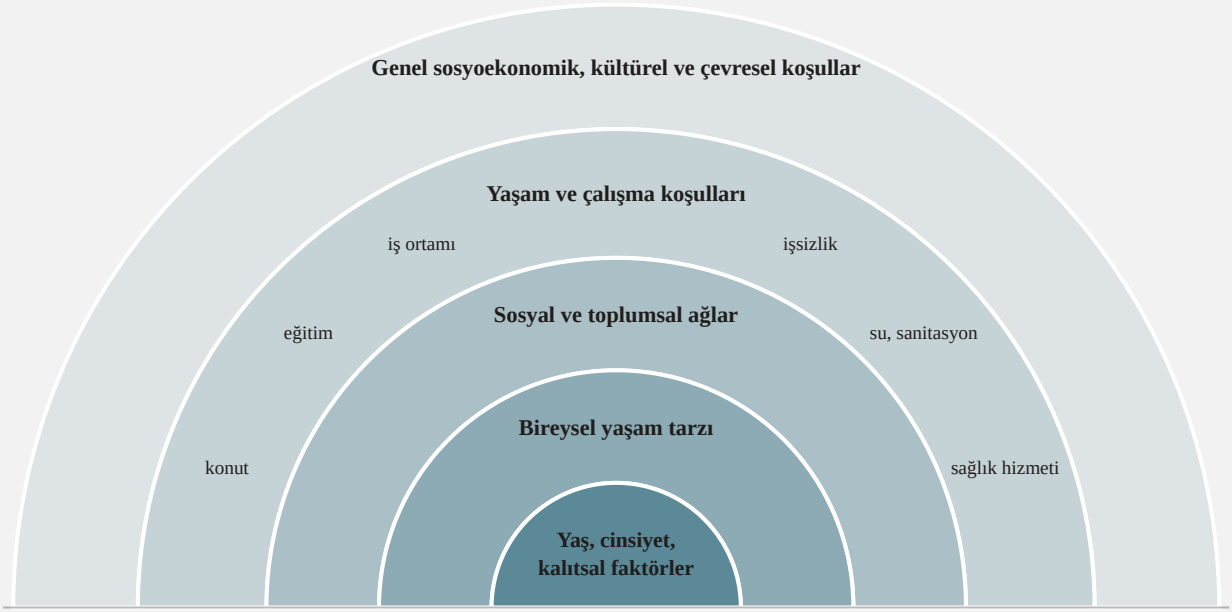
| Alan | İçeriği | Solunum sağlığından bir örnek |
|---|---|---|
| **Ekonomik istikrar** | Gelir, iş güvencesi, yoksulluk, gıda güvencesi | İlacını alamayan astımlı hasta. Isınmak için biyokütle yakan aile |
| **Eğitime erişim ve eğitimin kalitesi** | Okuryazarlık, eğitim düzeyi, sağlık okuryazarlığı | İnhaler tekniğini öğrenemeyen hasta. Sigara içme sıklığı eğitim düzeyi düştükçe artar |
| **Sağlık hizmetine erişim ve kalitesi** | Sağlık güvencesi, hekime ulaşım, birinci basamak | Spirometri yapılmadığı için geç tanınan KOAH |
| **Mahalle ve yapılı çevre** | Konut, hava kalitesi, su, güvenlik, ulaşım | Rutubetli evde küf ve akar maruziyeti. Kalabalık evde tüberküloz bulaşı |
| **Sosyal ve toplumsal bağlam** | Sosyal destek, ayrımcılık, toplumsal katılım | Yalnız yaşayan yaşlı KOAH hastasında ilaç kullanımının aksaması |

## 2.2. Dahlgren ve Whitehead modeli

Belirleyicilerin birbirleriyle ilişkisini en iyi gösteren model, Göran Dahlgren ve Margaret Whitehead'in 1991'de geliştirdiği "gökkuşağı" modelidir (Şekil 2.1). Model belirleyicileri iç içe halkalar olarak çizer:

1. **Merkez: yaş, cinsiyet ve kalıtsal faktörler.** Değiştirilemez. $\alpha_1$-antitripsin eksikliği ya da astıma genetik yatkınlık bu halkadadır.
2. **Bireysel yaşam tarzı:** sigara, beslenme, fiziksel aktivite, alkol. Değiştirilebilir, ama dış halkaların sınırları içinde.
3. **Sosyal ve toplumsal ağlar:** aile, arkadaşlar, komşular, toplumsal destek. Davranışları destekleyebilir ya da baskılayabilir.

4. **Yaşam ve çalışma koşulları:** tarım ve gıda üretimi, eğitim, çalışma ortamı, işsizlik, su ve sanitasyon, sağlık hizmetleri, konut.
5. **Genel sosyoekonomik, kültürel ve çevresel koşullar:** ekonomik düzen, gelir dağılımı, vergi ve sosyal güvenlik politikaları, kültürel normlar, iklim.




İçeriden dışarıya: bireyin değiştirebileceğinden toplumun ve politikanın değiştirebileceğine.
Yaşam ve çalışma koşulları halkası ayrıca tarım ve gıda üretimini kapsar (Dahlgren ve Whitehead, 1991).
Dış halkalar "nedenlerin nedenleri"dir: iç halkalardaki davranış ve riskleri biçimlendirir.

*Şekil 2.1 — Sağlığın belirleyicileri: Dahlgren ve Whitehead modeli. İç halkalar bireye yakın, dış halkalar yapısal belirleyicilerdir. Dış halkalar iç halkaları biçimlendirir: bir kişinin sigara içmesi (halka 2), arkadaş çevresinden (halka 3), iş yerindeki strese (halka 4) ve tütün vergilerinden (halka 5) etkilenir.*

Modelin temel mesajı şudur: iç halkalardaki risk faktörleri, dış halkalardaki koşulların sonucudur. Bu yüzden dış halkalara "nedenlerin nedenleri" denir. KOAH'ı yalnızca "sigara içen kişinin hastalığı" olarak görmek, halka 2'de durmak demektir. Oysa sigara içme sıklığı eğitim ve gelir düştükçe artar, ağır işlerde çalışanlar mesleki toza maruz kalır, yoksul kırsal evlerde yemek biyokütleyle pişirilir (Kitap 1). Sağlık politikası etkili olmak istiyorsa dış halkalara uzanmalıdır: tütün vergisi, kapalı alanda sigara yasağı, iş sağlığı mevzuatı ve temiz enerjiye erişim, bireye "sigarayı bırak" demekten daha çok insanın sağlığını korur.

## 2.3. Black Raporu

Sağlıktaki sosyal eşitsizliklerin bilimsel ve politik gündeme girmesini sağlayan belgelerden biri İngiltere'deki Black Raporu'dur. İngiltere Sağlık Bakanlığı 1977'de Sir Douglas Black başkanlığında bir çalışma grubu kurdu. Sorulan soru şuydu: 1948'den beri herkese ücretsiz hizmet veren Ulusal

Sağlık Hizmeti'ne (NHS) rağmen sosyal sınıflar arasındaki sağlık farkları neden sürüyor? 1980'de yayımlanan raporun bulguları şunlardı:

- Mesleğe göre tanımlanan beş sosyal sınıfın hepsinde, sınıf düştükçe ölüm hızları basamak basamak artıyordu. Doğumda ve yaşamın ilk ayında, vasıfsız işçi ailelerinin (V. sınıf) bebeklerinin ölüm oranı profesyonel meslek sahibi ailelerin (I. sınıf) bebeklerinin yaklaşık iki katıydı.
- Farklar, ücretsiz sağlık hizmetine rağmen azalmamış, bazı göstergelerde artmıştı. Yani eşitsizliğin nedeni yalnızca hizmete erişim değildi.

Rapor bu farklar için dört olası açıklamayı inceledi: **artefakt** (farkın ölçüm yönteminden kaynaklanan bir yanılsama olduğu), **doğal ya da sosyal seçilim** (hasta insanların işini kaybedip alt sınıflara düşmesi: Whitehead'in yedinci maddesi), **kültürel ve davranışsal açıklama** (alt sınıflarda sigara, kötü beslenme gibi davranışların sıklığı) ve **materyalist ya da yapısal açıklama** (gelir, konut, iş koşulları ve çevre). Rapor en önemli açıklamanın materyalist açıklama olduğu sonucuna vardı ve çocuk yoksulluğuyla mücadeleyi önerdi. Önerilerin maliyetli bulunması nedeniyle rapor çok sınırlı sayıda basılarak yayımlandı, ama zamanla sağlıkta eşitsizlik araştırmalarının temel metinlerinden biri oldu.

### 2.4. Sosyal gradyan

Black Raporu'nun en önemli gözlemi, sağlığın yalnızca "yoksullar" ile "diğerleri" arasında değil, sosyal merdivenin her basamağında farklılaşmasıdır. Bu olgu **sosyal gradyan** olarak adlandırılır. Michael Marmot'un İngiliz devlet memurları üzerinde yaptığı Whitehall çalışmaları bunu çarpıcı biçimde gösterdi: hiçbiri yoksul olmayan, hepsi masa başında çalışan ve aynı sağlık hizmetini alan memurlar arasında, en alt kademedekilerin ölüm hızı en üst kademedekilerin yaklaşık üç katıydı. Ölüm hızı kademe düştükçe her basamakta artıyordu.

Gradyanın varlığı, eşitsizliğin yalnızca maddi yoksunlukla açıklanamayacağını gösterir. Sosyal konum sağlığa birkaç yoldan yansır:

- **Maddi yol:** gelir; beslenmeyi, konutu, ısınmayı, ilaca ve hizmete erişimi belirler.
- **Psikososyal yol:** düşük sosyal konum, işi üzerinde az denetim, güvencesizlik ve kronik stres demektir. Kronik stres hipotalamus-hipofiz-adrenal eksenini ve sempatik sistemi sürekli uyarır. Kan basıncı, kan şekeri ve inflamasyon belirteçleri yükselir.
- **Davranışsal yol:** sigara, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alt sosyal gruplarda daha sıktır. Bu davranışlar çoğu zaman özgür seçim değil, koşulların daralttığı seçeneklerdir (Whitehead'in dördüncü maddesi).
- **Hizmet yolu:** ters bakım yasası. Alt gruplar daha geç tanı alır ve daha düşük kaliteli bakım görür.

- **Yaşam boyu birikim:** düşük doğum ağırlığı, çocukluktaki beslenme yetersizliği ve pasif sigara içiciliği akciğer gelişimini kısıtlar. Bu kişiler erişkinliğe daha düşük bir akciğer fonksiyonu tavanıyla başlar ve KOAH'a daha erken ulaşır (Kitap 1).

Gradyanın politika açısından anlamı şudur: yalnızca en yoksul grubu hedefleyen programlar eşitsizliği tam olarak çözmez. Marmot'un önerisi "orantılı evrenselcilik"tir: hizmetler herkese sunulmalı, ama yoğunluğu dezavantaj düzeyiyle orantılı olarak artmalıdır. Bu, Bölüm 1'deki dikey hakkaniyetin uygulamadaki karşılığıdır.

## Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU 1 (YENİ)

**Dahlgren ve Whitehead modelinde en dış halkada yer alan belirleyiciler aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Yaş, cinsiyet ve kalıtsal faktörler · B) Bireysel yaşam tarzı faktörleri · C) Sosyal ve toplumsal ağlar · D) Genel sosyoekonomik, kültürel ve çevresel koşullar · E) Sağlık hizmetleri ve konut

**Doğru: D.** En dış halka genel sosyoekonomik, kültürel ve çevresel koşullardır. Bunlar iç halkalardaki bütün belirleyicileri biçimlendiren "nedenlerin nedenleri"dir.

A modelin merkezidir. B ikinci, C üçüncü halkadır. E'deki sağlık hizmetleri ve konut dördüncü halkanın (yaşam ve çalışma koşulları) bileşenleridir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 2 (YENİ)

**Black Raporu'nun, sosyal sınıflar arasındaki sağlık farklarını açıklamada en önemli bulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Artefakt açıklaması · B) Doğal seçilim açıklaması · C) Kültürel ve davranışsal açıklama · D) Materyalist ve yapısal açıklama · E) Genetik açıklama

**Doğru: D.** Rapor, gelir, konut, çalışma koşulları ve çevre gibi maddi ve yapısal etkenleri sağlık farklarının en önemli açıklaması olarak gördü ve çocuk yoksulluğuyla mücadeleyi önerdi.

A (farkın ölçüm hatası olduğu), B (hastaların alt sınıflara düşmesi) ve C (davranış farkları) raporun incelediği diğer açıklamalardır ve tek başlarına farkları açıklamakta yetersiz bulunmuştur. E raporun dört açıklaması arasında yoktur.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 3 (YENİ)

**Whitehall çalışmalarında, hiçbiri yoksul olmayan devlet memurlarında ölüm hızının kademe düştükçe basamak basamak artması hangi kavramı gösterir?**

A) Ters bakım yasası · B) Sosyal gradyan · C) Sağlıklı işçi etkisi · D) Artefakt · E) Yatay hakkaniyet

**Doğru: B.** Sosyal gradyan, sağlığın sosyal merdivenin her basamağında konuma göre değişmesidir. Gradyanın yoksul olmayanlar arasında da görülmesi, sosyal konumun maddi yoksunluğun ötesinde (iş üzerindeki denetim, stres) etkileri olduğunu gösterir.

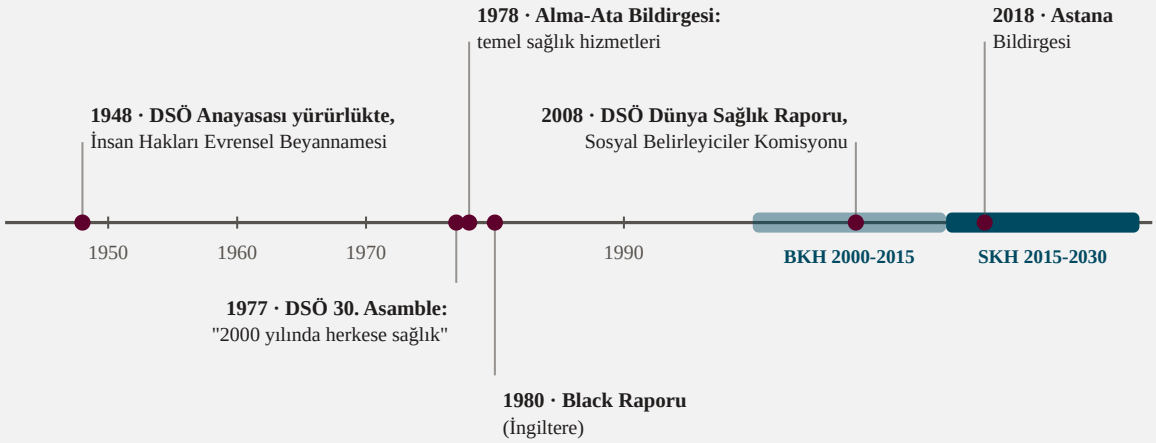
A hizmet dağılımıyla ilgilidir. C, çalışanların genel nüfustan sağlıklı olmasından doğan bir seçilim yanlılığıdır. D ölçüm kaynaklı yanılsamadır. E bir hakkaniyet ilkesidir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

# Tarihsel Süreç ve Uluslararası Belgeler

*Sağlıkta eşitlik fikri, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından sağlığın bir insan hakkı olarak tanımlanmasıyla uluslararası belgelere girdi. Sonraki yetmiş yılda aynı fikir her on-yirmi yılda bir yeni bir belgeyle yeniden ifade edildi, çünkü her belgenin ardından yapılan değerlendirme eşitsizliklerin sürdüğünü, hatta arttığını gösterdi. Bu bölüm o belgeleri sırayla anlatır (Şekil 3.1). Sınav açısından en önemlileri Alma-Ata Bildirgesi, 2008 DSÖ raporunun beş temel sorunu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Astana Bildirgesidir.*

## 3.1. Zaman çizelgesi




*Şekil 3.1 — Sağlıkta eşitlik için uluslararası belgeler. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (BKH, 2000-2015) ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH, 2015-2030) çizgi üzerinde dönemler olarak gösterilmiştir.*

## 3.2. Bir hak olarak sağlık: 1948 ve 1977

Birleşmiş Milletler'in **İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948)** sağlığı insan haklarının içine yerleştirdi. Sunum ilkeyi şöyle özetler: **herkes ırk, dil, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıklı olma temel hakkına sahiptir**. Beyannamenin 25. maddesi herkesin kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için yeterli bir yaşam düzeyine (beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ve sosyal hizmetler) hakkı olduğunu söyler. Aynı yıl yürürlüğe giren DSÖ Anayasası da en yüksek sağlık düzeyine ulaşmayı ayrım gözetmeksizin herkesin temel hakkı sayar (Bölüm 1.1).

**1977'de DSÖ'nün 30. Dünya Sağlık Asamblesi** bu hakkı somut bir hedefe dönüştürdü: **bütün insanları mümkün olan en üst düzeyde sağlığa ulaştırmak**. Hedefin sloganı **"2000 yılında herkese sağlık"** oldu.

### 3.3. Alma-Ata Bildirgesi (1978)

"Herkese sağlık" hedefine nasıl ulaşılacağı ertesi yıl, Eylül 1978'de DSÖ ve UNICEF'in Alma-Ata'da (bugünkü Kazakistan) düzenlediği uluslararası konferansta tanımlandı. Alma-Ata Bildirgesi'nin ana fikri şudur: **herkese sağlığa ulaşmanın anahtarı temel sağlık hizmetleridir** (birinci basamak). Bildirge, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki sağlık eşitsizliğini **siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan kabul edilemez** olarak niteledi.

Bildirgeye göre temel sağlık hizmetleri en az şu bileşenleri içermelidir: sağlık eğitimi, beslenme ve gıda güvenliği, güvenli su ve temel sanitasyon, aile planlaması dahil ana-çocuk sağlığı, başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama, yerel endemik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, sık görülen hastalık ve yaralanmaların uygun tedavisi ve temel ilaçların sağlanması. Listenin büyük kısmının hastanede değil toplumun içinde yapılan işlerden oluşması, bildirgenin sağlığın sosyal belirleyicilerini erken fark ettiğini gösterir.

### 3.4. Alma-Ata'dan 30 yıl sonra: 2008 DSÖ raporu

DSÖ, Alma-Ata'nın 30. yılında yayımladığı 2008 Dünya Sağlık Raporu'nda ("Temel Sağlık Hizmetleri: Şimdi Her Zamankinden Daha Gerekli") bir değerlendirme yaptı. Raporun üç tespiti şunlardır: **son 30 yılda eşitsizlikler daha da artmıştır**, **sağlık sorunları zaman içinde değişmiştir** (bulaşıcı hastalıkların yanında kronik hastalıklar, yaşlanma, kentleşme) ve **ekonomik ve politik krizler sonucu sağlık hizmetlerinde finansman, insan gücü ve diğer altyapı sorunları artmıştır**.

Rapor, sağlık sistemlerinin hakkaniyeti bozan **beş temel sorununu** sayar:

| Sorun | Anlamı |
|---|---|
| **1. Tersine hizmet** | Hizmete en çok ihtiyacı olanlar en az hizmeti alır. En çok hizmeti ihtiyacı en az olan varlıklı gruplar tüketir (ters bakım yasası, Bölüm 1.3) |
| **2. Fakirleştiren hizmet** | Sosyal güvencenin olmadığı yerde hizmet için cepten ödeme yapmak zorunda kalan aileler yoksullaşır. Her yıl milyonlarca insan sağlık harcamaları nedeniyle yoksulluğa düşer |
| **3. Parçalı hizmet** | Uzmanlaşma ve tek bir hastalığa odaklanan dikey programlar hizmetin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozar |
| **4. Güvensiz hizmet** | Düşük kaliteli, hatalı ya da hastaya zarar veren uygulamalar (yanlış ilaç, hastane enfeksiyonları) |
| **5. Yanlış yönlü hizmet** | Kaynakların pahalı tedavi hizmetlerine ve hastanelere ayrılması, koruma ve sağlığı geliştirmenin ihmal edilmesi |

Rapor bu sorunlara karşı dört reform alanı önerir: **(1) herkesi kapsayan, hakça ve sosyal adaleti gözeten sağlık güvencesi** (evrensel kapsam reformları), **(2) yeni ihtiyaçları ve beklentileri karşılayan hizmet sunum reformları**, **(3) bütün sektörlerin sağlıkla ilgili sorumluluklarını dikkate alan ve sektörler arası işbirliğini sağlayan kamu politikası reformları** ve **(4) katı merkeziyetçi yönetim yerine katılımcı, tartışmaya dayalı liderlik reformları**. Sunuma göre

reformlar **hakça olmalı, yeni sağlık tehditlerine karşı etkili olmalı ve toplumların beklentilerini karşılayabilmelidir**.

Aynı yıl DSÖ'nün Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu da (başkanı Michael Marmot) "Bir Kuşakta Farkı Kapatmak" raporunu yayımladı. Komisyonun üç eylem ilkesi Bölüm 5.5'te anlatılmaktadır.

## 3.5. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (2000-2015)

Eylül 2000'de Birleşmiş Milletler Bin Yıl Zirvesi'nde 189 ülke, 2015'e kadar ulaşılacak sekiz hedef belirledi. Hedeflerin üçü doğrudan sağlıkla, diğerleri sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgilidir:

**Bin Yıl Kalkınma Hedefleri**

1. Mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak · 2. Herkesin temel eğitim almasını sağlamak · 3. Kadınların konumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek · **4. Çocuk ölümlerini azaltmak** · **5. Anne sağlığını iyileştirmek** · **6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele etmek** · 7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması · 8. Kalkınma için küresel ortaklıklar geliştirmek

Hedeflere kısmen ulaşıldı: aşırı yoksulluk ve beş yaş altı ölüm hızı belirgin azaldı. Ancak ilerleme ülkeler ve gruplar arasında çok eşitsiz oldu ve kronik hastalıklar, ruh sağlığı ve çevre gibi alanlar dışarıda kaldı. Bu eksiklikler bir sonraki gündemi biçimlendirdi.

## 3.6. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (2015-2030)

2015'te Birleşmiş Milletler, 2030'a kadar ulaşılacak 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) kabul etti. SKH'ler BKH'lerden üç noktada ayrılır: yalnızca gelişmekte olan ülkeleri değil bütün ülkeleri kapsar, "kimseyi geride bırakmamak" ilkesiyle ülke içi eşitsizlikleri hedefe koyar ve eşitsizliklerin azaltılmasını ayrı bir hedef (SKH 10) yapar. Sağlıkla ilgili ana hedef SKH 3'tür ("Sağlıklı bireyler") ve alt hedefleri Bölüm 4'te rakamlarıyla anlatılır. Sunumda her hedef için verilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

| Hedef | Sunumdaki vurgu |
|---|---|
| 1. Yoksulluğa son | 800 milyondan fazla insan günde 1,25 ABD dolarından az gelirle geçiniyor. Kadınlar dezavantajlı. Yoksulların %80'i Güney Asya ve Sahra altı Afrika'da |
| 2. Açlığa son | Beş yaş altında 90 milyonu aşkın çocuk gerekli ağırlığın altında. Küçük çiftçiler ve sürdürülebilir tarım desteklenmeli |
| **3. Sağlıklı bireyler** | Her yıl 6 milyondan fazla çocuk 5 yaşından önce ölüyor. Kırsalda doğumların yalnızca %56'sı profesyonel doğum hizmeti alıyor. HIV Afrika'da ergenlerde ilk ölüm nedeni |
| 4. Nitelikli eğitim | Yoksul ailelerin çocuklarının okulu bırakma olasılığı varlıklılarınkinin 4 katı. 2015'te okullaşma %95, 2030 hedefi %100 |
| 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği | Cinsel şiddet ve istismar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz bölüşümü, kamu görevlerinde ayrımcılık |

| Hedef | Sunumdaki vurgu |
|---|---|
| 6. Temiz su ve sıhhi koşullar | Su kıtlığı, kuraklık, çölleşme. 2030'a kadar herkese güvenli içme suyu |
| 7. Erişilebilir ve temiz enerji | Her 5 kişiden 1'inin elektriğe erişimi yok. Güneş ve rüzgâr enerjisine yatırım |
| 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme | Tam ve üretken istihdam. Zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretinin ortadan kaldırılması |
| 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı | İnternet erişimi olmayan 4 milyardan fazla insan. Dijital eşitsizliğin giderilmesi |
| **10. Eşitsizliklerin azaltılması** | En zengin %10, toplam küresel gelirin %40'ını elde ediyor. Herkesin ekonomik katılımını destekleyen politikalar |
| 11. Sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları | Kırdan kente göç, güvenli konut, toplu taşıma, kentsel planlama |
| 12. Sorumlu tüketim ve üretim | Zehirli atıkların bertarafı, geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı |
| 13. İklim eylemi | İklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri |
| 14. Sudaki yaşam | Okyanuslar karbondioksitin %30'unu emer. Okyanusun her kilometrekaresinde ortalama 13 bin plastik atık |
| 15. Karasal yaşam | Ekilebilir arazi kaybı, çölleşme, biyoçeşitlilik kaybı |
| 16. Barış ve adalet | Çatışma, şiddet ve istismarın azaltılması, hukukun üstünlüğü |
| 17. Hedefler için ortaklıklar | Teknoloji ve bilgiye erişim, gelişmekte olan ülkelerin borç yönetimi, yatırımın teşviki |

## 3.7. Astana Bildirgesi (2018)

Alma-Ata'nın 40. yılında, 25-26 Ekim 2018'de yine Kazakistan'da (Astana) toplanan Küresel Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı, Alma-Ata'nın ilkelerini yeniledi. Sunumdaki üç taahhüt şunlardır:

1. **Her insanın hiçbir ayrım gözetmeden, temel hakları olan erişilebilecek en yüksek sağlık standartlarına kavuşmasına bağlılığımızı güçlü bir şekilde teyit ederiz.**
2. **Evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleşmesinin ve herkesin, hizmeti alırken parasal zorluğa düşmeden, ihtiyaç duyduğu eşit derecede kaliteli ve etkili sağlık hizmetlerine erişebilmesinin takipçisi olacağız.**
3. **Sağlıkta eşitsizliğin ve sağlık çıktılarındaki farklılıkların devam etmesini etik, politik, sosyal ve ekonomik olarak kabul edilemez buluyoruz.**

Sunum, Alma-Ata ve Astana bildirgelerinde ortak olarak vurgulanan 16 noktayı sıralar. Bunlar üç grupta toplanınca akılda kalır:

| Hakkaniyet ve kapsam | Hizmetin niteliği | Yönetim ve kalkınma |
|---|---|---|
| Sosyal gruplar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi | İnsanın çevresiyle bir bütün olarak ele alınması | Toplumun sağlık hizmetine katılımı |
| Hizmetlerin herkesi kapsaması | Güçlü bir birinci basamak | Sektörler arası işbirliği |
| Yoksulluğun azaltılmasının sağlığa olumlu yansıması | Hizmetlerin sürekliliği | Sağlık yatırımlarının genel kalkınmaya katkısı |
| Beslenme sorunlarının giderilmesi | Ekip anlayışı | Hükümetlerin kararlı tutumu |
| Hizmetlerin ticarileştirilmesinin önlenmesi | Bütüncül yaklaşım | Uluslararası dayanışma |
| | Hekim dışı personelin önemi | |

2018 bildirgesi, Alma-Ata'dan bu yana değişen koşulları da kaydeder: **yaşam süresinin uzaması, tıptaki hızlı gelişmeler, küreselleşme, artan göç hareketleri, maliyetlerin artması, toplumlardaki sağlık sorunlarının farklılaşması ve ruh sağlığı sorunlarının, bulaşıcı olmayan hastalıkların ve yaşlı bakımının ön plana çıkması**. KOAH, bu yeni tablonun tipik bir hastalığıdır: kronik, yaşlanmayla artan ve sosyal gradyanı belirgin bir hastalık.

## Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU 1 (YENİ)

**Alma-Ata'dan 30 yıl sonra yayımlanan 2008 DSÖ raporunda sayılan sağlık sistemlerinin beş temel sorunundan biri değildir?**

A) Tersine hizmet · B) Fakirleştiren hizmet · C) Parçalı hizmet · D) Güvensiz hizmet · E) Merkezi hizmet

**Doğru: E.** Beş temel sorun tersine hizmet, fakirleştiren hizmet, parçalı hizmet, güvensiz hizmet ve yanlış yönlü hizmettir. "Merkezi hizmet" bu listede yoktur. Rapor katı merkeziyetçi yönetimi eleştirir, ama bunu ayrı bir reform alanı (liderlik reformları) olarak ele alır.

A ihtiyacı en çok olanın en az hizmet almasıdır. B cepten ödemelerin aileleri yoksullaştırmasıdır. C hizmetin bütünlüğünün bozulmasıdır. D hatalı ve zarar veren hizmettir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 2 (YENİ)

### "Herkese sağlık" hedefine ulaşmanın anahtarı olarak temel sağlık hizmetlerini tanımlayan ve sağlık eşitsizliğini siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan kabul edilemez olarak niteleyen belge hangisidir?

A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) · B) Alma-Ata Bildirgesi (1978) · C) Black Raporu (1980) · D) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (2000) · E) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (2003)

**Doğru: B.** DSÖ ve UNICEF'in 1978'de Alma-Ata'da düzenlediği konferansın bildirgesi, temel sağlık hizmetlerini "2000 yılında herkese sağlık" hedefinin anahtarı olarak tanımladı.

A sağlığı bir insan hakkı olarak tanımlar. C İngiltere'de sosyal sınıflar arası sağlık farklarını inceleyen rapordur. D, 2000-2015 için sekiz kalkınma hedefidir. E tütün kontrolüne yönelik uluslararası sözleşmedir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 3 (YENİ)

### Aşağıdakilerden hangisi Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'nden biri değildir?

A) Çocuk ölümlerini azaltmak · B) Anne sağlığını iyileştirmek · C) HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele etmek · D) Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı erken ölümleri üçte bir azaltmak · E) Herkesin temel eğitim almasını sağlamak

**Doğru: D.** Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı erken ölümlerin üçte bir azaltılması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin bir alt hedefidir (SKH 3.4). Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kronik hastalıkları kapsamıyordu. Bu eksiklik SKH'lerde giderildi.

A, B, C ve E, sekiz Bin Yıl Kalkınma Hedefi'nin arasındadır (sırasıyla 4, 5, 6 ve 2. hedefler).

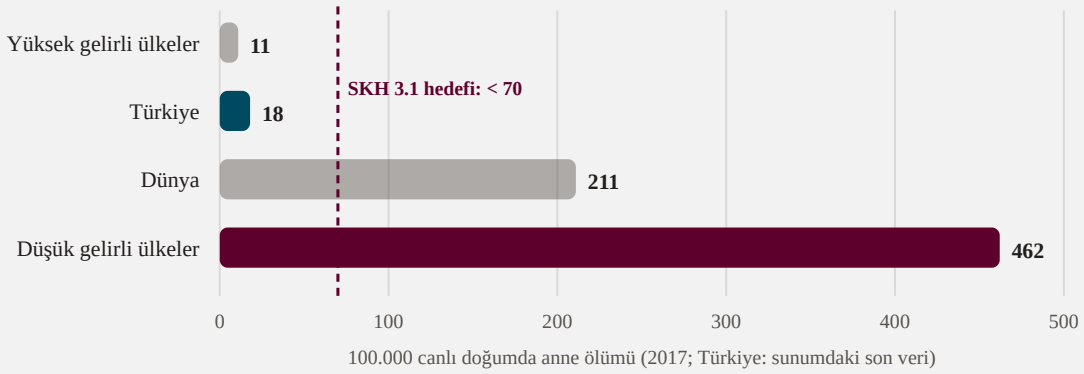
*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

# Rakamlarla Küresel Eşitsizlik

*Sunumun büyük kısmı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3'ün alt hedeflerine ait DSÖ verilerinden oluşur. Bu verilerin hepsinde aynı örüntü tekrarlanır: bir sağlık sorununun küresel yükünün büyük kısmı düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da toplanır. Ülkelerin içinde de yük yoksul, kırsal ve eğitimsiz gruplarda yoğunlaşır. Bu bölüm rakamları tek tek ezberlemek için değil, bu örüntüyü görmek için okunmalıdır. Yine de sınavda sorulabilecek birkaç sayı (SKH 3.1 hedefi, küresel ve Türkiye anne ölüm oranı, 90-70-90 hedefi) kalın yazılmıştır.*

## 4.1. SKH 3.1: anne ölümleri

Anne ölüm oranı, gebelik sırasında ya da gebeliğin sona ermesinden sonraki 42 gün içinde, gebelikle ilgili ya da gebelikle ağırlaşan nedenlerle ölen kadın sayısının 100.000 canlı doğuma oranıdır. Hedef: **küresel anne ölüm oranını 100.000 canlı doğumda 70'in altına düşürmek ve hiçbir ülkede küresel ortalamanın 2 katından fazla olmamasını sağlamak**. Tahmini **2017 küresel anne ölüm oranı 211'dir** (belirsizlik aralığı 199-243).




*Şekil 4.1 — Anne ölüm oranı (100.000 canlı doğumda, 2017). Düşük gelirli ülkelerde oran yüksek gelirli ülkelerin 40 katından fazladır. Türkiye'nin son verisi (18) SKH hedefinin (kesikli çizgi) çok altındadır ve yüksek gelirli ülkelere yakındır.*

Sunumdaki diğer bilgiler:

- **Sahra altı Afrika ve Güney Asya, 2017'deki tahmini küresel anne ölümlerinin yaklaşık %86'sından sorumludur.** Gelişmekte olan ülkeler yıllık anne ölümlerinin %99'unu oluşturur.
- **2017'de düşük gelirli ülkelerde anne ölüm oranı 100.000 canlı doğumda 462, yüksek gelirli ülkelerde 11'dir. Türkiye'de son verilere göre 18'dir.**
- Çad'da bir kadının yaşamı boyunca gebelik nedeniyle ölme riski 16'da 1, İsveç'te 10.000'de 1'den azdır.
- Anne ölüm riski **15 yaş altı ergenlerde** daha yüksektir. Gebelik ve doğum komplikasyonları **10-19 yaş** arasındaki ergenlerde daha sıktır.

Ölümlerin çoğuna yol açan komplikasyonlar gebelik ve doğum sırasında ortaya çıkar: **(1) şiddetli kanama, (2) enfeksiyon, (3) gebelikte yüksek tansiyon (preeklampsi, eklampsi), (4) doğum kaynaklı komplikasyonlar, (5) güvenli olmayan düşükler**. Bu nedenlerin hepsi bilinen ve ucuz yöntemlerle önlenebilir ya da tedavi edilebilir: doğum sonu kanamada oksitosin, enfeksiyonda antibiyotik, preeklampside magnezyum sülfat ve zamanında doğum. Bu yüzden anne ölüm oranı sağlık eşitsizliğinin en duyarlı göstergelerinden biridir: kadının nitelikli bir sağlık personeline, kana, ulaşıma ve acil obstetrik bakıma zamanında ulaşıp ulaşamadığını, yani sağlık sisteminin bütününü ölçer.

DSÖ'nün önlenebilir anne ölümlerini sona erdirme stratejisi beş başlık içerir: üreme, anne ve yenidoğan sağlık hizmetlerine erişim ve kalitedeki eşitsizlikleri ele almak, bu hizmetler için evrensel sağlık kapsamını sağlamak, üreme ve anne hastalıklarına ilişkin engellerin bütün nedenlerini ele almak, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yüksek kaliteli veri toplayan sağlık sistemleri kurmak ve bakım kalitesi ile hakkaniyet için hesap verebilirliği sağlamak.

## 4.2. SKH 3.2: yenidoğan ve çocuk ölümleri

Hedef: yenidoğan bebeklerin ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerine son vermek (2030'a kadar yenidoğan ölüm hızını binde 12'nin, 5 yaş altı ölüm hızını binde 25'in altına indirmek). Sunumdaki veriler:

- **5 yaş altı ölüm hızı 1990'da binde 93'ten 2019'da binde 38'e düşmüştür.** İlerleme büyüktür, ama eşitsizdir.
- 2019'da **5 yaş altı ölümlerin %47'si yenidoğan döneminde** gerçekleşmiştir. Çocuk ölümleri azaldıkça ölümler giderek ilk 28 güne toplanır, çünkü yenidoğan ölümlerini azaltmak (doğumda nitelikli personel, yenidoğan canlandırma, ısı koruması) aşı ve ishal tedavisinden daha karmaşık bir sistem gerektirir.
- 2019'da **7,4 milyon çocuk ve ergen (0-14 yaş)** önlenebilir ve tedavi edilebilir nedenlerle ölmüştür. Her gün yaklaşık 16.000 çocuk beşinci doğum gününden önce ölmektedir.
- En yüksek 5 yaş altı ölüm hızı DSÖ Afrika Bölgesi'ndedir: **Avrupa Bölgesi'nin yaklaşık 9 katı**. Sahra altı Afrika'da 5 yaşından önce ölmek, dünyanın geri kalanından 14 kat daha olasıdır. Kırsal ve yoksul hanelerin çocukları orantısız olarak etkilenir.
- 2019'da en çok yenidoğan ölümünün olduğu ülkeler: Hindistan (522 bin), Nijerya (270 bin), Pakistan (248 bin), Etiyopya (99 bin), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (97 bin), Çin (64 bin), Endonezya (60 bin), Bangladeş (56 bin), Afganistan ve Tanzanya (43'er bin). Bu listede nüfus büyüklüğü ile hizmet eksikliği birlikte rol oynar.

## 4.3. SKH 3.3 ve 3.4: bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar

**SKH 3.3**, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalıkların salgınlarını sona erdirmeyi ve hepatit, su yoluyla bulaşan ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi hedefler. DSÖ'nün 2016-2021 HIV küresel sağlık sektörü stratejisinin beş stratejik yönü: **odaklanmış eylem için bilgi** (salgınınızı ve yanıtınızı bilin), **etki müdahaleleri** (gerekli hizmet yelpazesi), **eşitlik** (hizmete ihtiyaç duyan nüfusa ulaşmak), **sürdürülebilirlik için finansman** ve **hızlanma için yenilik**.

**Tüberküloz yoksulluğun hastalığıdır.** Küresel tüberküloz yükünün üçte ikisi sekiz ülkede yoğunlaşmıştır ve tüberküloz ölümlerinin yaklaşık %95'i gelişmekte olan ülkelerdedir. Bu ölümler çoğunlukla genç yetişkinleri en üretken dönemlerinde etkiler. Yoksulluk tüberkülozu üç yoldan besler: kalabalık ve havasız konut bulaşı kolaylaştırır, yetersiz beslenme ve HIV bağışıklığı zayıflatır, tanı ve tedaviye geç ulaşma bulaşıcılık süresini uzatır. Hastalık da aileyi gelir kaybıyla yoksullaştırır ve kısır döngü kapanır.

**SKH 3.4**, önleme ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri üçte bir azaltmayı ve ruh sağlığı ile refahı desteklemeyi hedefler. Bulaşıcı olmayan hastalıklar **bütün dünyadaki ölümlerin %71'ine** denk gelir. Dört ana grup: **kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları, kanserler ve diyabet**. Kronik solunum yolu hastalıklarının başında bu modülün konusu olan KOAH ve astım gelir. Erken ölümlerin **%85'i (DSÖ'nün on gerçeğinde %87'si) düşük ve orta gelirli ülkelerde** görülür. Bu hastalıkların uzun süreli tedavi maliyetleri insanları yoksulluğa sürükler. Ruh sağlığı açısından, her yıl yaklaşık 703.000 kişi intihar sonucu ölmektedir.

## 4.4. SKH 3.7 ve 3.8: üreme sağlığı ve evrensel sağlık kapsamı

**SKH 3.7** cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimi hedefler. Sunuma göre 1,1 milyar kadının aile planlaması ihtiyacı vardır. Kadınların %76,8'i aile planlaması ihtiyacını modern yöntemlerle karşılayabilmektedir. Her yıl 10 milyon adölesan gebelik meydana gelmektedir.

DSÖ'nün serviks kanserini bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarma stratejisine göre bütün ülkeler **100.000'de 4'ün altında** bir insidansa ulaşmalıdır. Bunun için 2030'a kadar ulaşılması gereken üç hedef **"90-70-90"** olarak özetlenir:

| **90** | **70** | **90** |
|---|---|---|
| **Aşılama:** kızların %90'ı 15 yaşına kadar HPV aşısıyla tam olarak aşılanmalı | **Tarama:** kadınların %70'i 35 yaşına kadar ve yine 45 yaşına kadar yüksek performanslı bir testle taranmalı | **Tedavi:** prekanseröz lezyonu olan kadınların %90'ı ve invaziv kanserli kadınların %90'ı tedavi edilmeli |

**SKH 3.8: evrensel sağlık kapsamı**, tüm bireylerin ve toplulukların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini **maddi sıkıntı çekmeden** almaları anlamına gelir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinden

önleme, tedavi, rehabilitasyon ve yaşam boyu palyatif bakıma kadar bütün temel ve kaliteli hizmetleri içerir. İnsanları sağlık hizmeti için kendi ceplerinden ödeme yapmanın mali sonuçlarından korur ve **yoksulluğa düşme riskini azaltır**. Bu, 2008 raporundaki "fakirleştiren hizmet" sorununun doğrudan çözümüdür.

### 4.5. SKH 3.9 ve 3.a: çevre ve tütün

**SKH 3.9** çevre kirliliğine bağlı ölüm ve hastalıkları azaltmayı hedefler. Sağlıklı bir çevrenin bileşenleri: temiz hava, istikrarlı iklim, yeterli su, sanitasyon ve hijyen, kimyasalların güvenli kullanımı, radyasyondan korunma, sağlıklı ve güvenli iş yeri, sağlıklı tarım uygulamaları ve sağlığı destekleyen şehirler. Sunumdaki veriler, bu modülün konusu olan solunum hastalıklarıyla doğrudan ilişkilidir:

- Tüm küresel ölümlerin **%24'ünün çevreyle bağlantılı** olduğu düşünülmektedir.
- **Kapalı alan hava kirliliğine bağlı her yıl 3,8 milyon ölüm** meydana gelir. Bunun başlıca kaynağı yemek pişirmek ve ısınmak için açık ateşte ya da verimsiz sobalarda yakılan biyokütledir. Maruz kalanlar en çok yoksul kırsal hanelerdeki kadınlar ve çocuklardır ve biyokütle dumanı sigara içmeyenlerde KOAH'ın en önemli nedenidir (Kitap 1).
- **Dünya nüfusunun %91'i**, hava kirliliğinin DSÖ kılavuz sınırlarını aştığı yerlerde yaşar. Dünya çapındaki şehirlerin %80'inden fazlası bu sınırları aşar. Hava kalitesi, sağlıklı ya da sağlıksız bir şehrin en iyi genel göstergelerinden biridir.
- Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın büyük şehirlerinde dış ortam hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 3 milyon insan kalp krizi, inme, solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseri nedeniyle erken ölmektedir.

**SKH 3.a**, DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bütün ülkelerde uygulanmasını güçlendirmeyi hedefler. **1,3 milyar insan tütün ürünleri kullanmaktadır. Bunların %80'i düşük ve orta gelirli ülkelerdedir** ve **tütün kullananların yarısı tütüne bağlı nedenlerden ölmektedir**. Tütün kontrolünün en etkili araçları (vergiler, kapalı alan yasakları, reklam yasağı, paket uyarıları) Dahlgren-Whitehead modelinin dış halkalarına etki eden politikalardır.

### 4.6. SKH 3.b ve 3.c: aşılar, ilaçlar ve sağlık iş gücü

**SKH 3.b**, öncelikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen hastalıklara yönelik aşı ve ilaçların araştırılmasını desteklemeyi ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimi sağlamayı hedefler. 2019'da 15 yaşındaki kızların yalnızca **%15'i** HPV aşısına sahipti. İnfantların **%85'i** üç doz DTP aşısıyla aşılanmıştı. **14 milyon çocuk** kızamık, difteri ve tetanoz aşılarını olamamıştı.

**SKH 3.c** sağlık iş gücünü güçlendirmeyi hedefler. Düşük ve orta gelirli ülkelerde **18 milyon** sağlık çalışanına ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 2030'a kadar **9 milyon hemşire ve ebeye** ihtiyaç vardır. Dünyada sağlık iş kolunda çalışanların **%70'i kadındır**. Ters bakım yasasının en somut nedeni sağlık çalışanlarının dağılımıdır: hekimler ve hemşireler varlıklı ülkelere ve ülkelerin içinde büyük şehirlere toplanır.

## 4.7. DSÖ'ye göre sağlık eşitsizlikleri hakkında on gerçek

| Gerçek | Kanıt |
|---|---|
| **1.** Sağlık eşitsizlikleri, sağlık sonuçlarındaki sistematik farklılıklardır | Adil değildir ve devlet politikalarının doğru karışımıyla azaltılabilir |
| **2.** Her gün 16.000 çocuk beşinci doğum gününden önce ölüyor | Sahra altı Afrika'da 5 yaşından önce ölmek dünyanın geri kalanından 14 kat daha olası. Kırsal ve yoksul hanelerin çocukları orantısız etkileniyor |
| **3.** Anne ölüm oranı sağlık eşitsizliğinin önemli bir göstergesidir | Gelişmekte olan ülkeler yıllık anne ölümlerinin %99'u. Yaşam boyu risk Çad'da 1/16, İsveç'te 1/10.000'den az |
| **4.** Tüberküloz yoksulluğun bir hastalığıdır | Tüberküloz ölümlerinin yaklaşık %95'i gelişmekte olan ülkelerde, çoğunlukla genç yetişkinlerde |
| **5.** Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı erken ölümlerin %87'si düşük ve orta gelirli ülkelerde | Bu hastalıkların maliyetleri insanları yoksulluğa sürüklüyor ve gelişmeyi baskılıyor |
| **6.** Yaşam beklentisi ülkeler arasında 34 yıla kadar değişiyor | Sierra Leone'de doğan bir çocuk 50, Japonya'da doğan bir çocuk 84 yıl yaşayabilir |
| **7.** Ülkelerin içinde de endişe verici eşitsizlikler var | ABD'de Afrikalı Amerikalılar nüfusun %13'ü, ama yeni HIV enfeksiyonlarının neredeyse yarısı. Bu farkın biyolojik ya da genetik bir nedeni yok |
| **8.** Şehirlerde sağlık eşitsizliği büyüktür | Aynı şehrin farklı semtlerinde bile yaşam beklentisi değişiyor |
| **9.** Sağlık eşitsizliklerinin toplumlar için önemli bir mali maliyeti var | Avrupa Parlamentosu'nun tahminine göre Avrupa Birliği'nde GSYİH'nın %1,4'ü |
| **10.** Kalıcı eşitsizlikler gelişmeyi yavaşlatır | Kentsel nüfusun yaklaşık dörtte biri gecekondu koşullarında yaşıyor (SKH 11 ile ilişkili) |

Yedinci gerçekteki ifade ("bu farkların biyolojik veya genetik bir sebebi yoktur") Bölüm 1'deki ayrımın kendisidir: fark biyolojik değilse kaçınılabilirdir. Kaçınılabilir ve sosyal koşullardan doğuyorsa adaletsizdir.

# Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU 1 (YENİ)

**Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3.1'e göre 2030 yılı için belirlenen küresel anne ölüm oranı hedefi aşağıdakilerden hangisidir?**

A) 100.000 canlı doğumda 11'in altı · B) 100.000 canlı doğumda 18'in altı · C) 100.000 canlı doğumda 70'in altı · D) 100.000 canlı doğumda 211'in altı · E) 1.000 canlı doğumda 25'in altı

**Doğru: C.** SKH 3.1, küresel anne ölüm oranını 100.000 canlı doğumda 70'in altına düşürmeyi ve hiçbir ülkenin küresel ortalamanın 2 katını aşmamasını hedefler.

A yüksek gelirli ülkelerin 2017 değeridir. B Türkiye'nin sunumdaki son değeridir. D 2017 küresel tahminidir. E, SKH 3.2'nin 5 yaş altı ölüm hızı hedefidir ve binde ifade edilir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 2 (YENİ)

**DSÖ'nün serviks kanserini eliminasyon stratejisindeki "90-70-90" hedeflerinde "70" neyi ifade eder?**

A) Kızların %70'inin 15 yaşına kadar HPV aşısıyla aşılanması · B) Kadınların %70'inin 35 ve 45 yaşına kadar yüksek performanslı bir testle taranması · C) Prekanseröz lezyonların %70'inin tedavi edilmesi · D) İnsidansın %70 azaltılması · E) Ölümlerin %70 azaltılması

**Doğru: B.** 90-70-90 sırasıyla aşılama (kızların %90'ı 15 yaşına kadar HPV aşılı), tarama (kadınların %70'i 35 ve 45 yaşına kadar taranmış) ve tedavidir (lezyonu ve kanseri olan kadınların %90'ı tedavi edilmiş).

A'daki oran %90 olmalıdır. C'deki tedavi hedefi %90'dır. D ve E stratejinin hedeflerinden değildir. Eliminasyon ölçütü insidansın 100.000'de 4'ün altına inmesidir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 3 (YENİ)

**Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan hava kirliliğiyle ilgili doğru bir ifadedir?**

A) Yalnızca yüksek gelirli ülkelerde görülen bir sorundur · B) Her yıl yaklaşık 3,8 milyon ölüme yol açar ve yükü en çok yoksul hanelerdeki kadın ve çocuklardadır · C) Solunum hastalıklarıyla ilişkisi gösterilmemiştir · D) Başlıca kaynağı trafik egzozudur · E) Sigara içmeyenlerde KOAH'ın nedenleri arasında yer almaz

**Doğru: B.** Kapalı alan hava kirliliğinin başlıca kaynağı yemek ve ısınma için yakılan biyokütledir. Yükü en çok yoksul kırsal hanelerde, ocak başında zaman geçiren kadınlarda ve çocuklarda toplanır.

A yanlış: sorun büyük ölçüde düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. C ve E yanlış: biyokütle dumanı sigara içmeyenlerde KOAH'ın en önemli nedenidir, çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarını artırır. D yanlış: trafik egzozu dış ortam hava kirliliğinin kaynağıdır.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

# Eşitsizliğin Ölçülmesi, Türkiye ve Mücadele

*Ölçülmeyen bir sorun görünmez kalır. Ülke ortalamaları bu açıdan yanıltıcıdır: bir ülkenin ortalama bebek ölüm hızı iyi görünürken en yoksul bölgesindeki hız ortalamanın birkaç katı olabilir. Bu bölüm eşitsizliğin hangi göstergelerle ve hangi araçlarla ölçüldüğünü anlatır, sunumdaki Türkiye verilerini grafiklere dönüştürür ve eşitsizliklerle mücadelenin ilkelerini ve hekimin bu mücadeledeki yerini tartışır.*

## 5.1. Ülkeler arası karşılaştırma: İnsani Gelişme Endeksi

Ülkelerin gelişmişliğini yalnızca ekonomik büyüklükle ölçmek, gelirin sağlık ve eğitime dönüşüp dönüşmediğini gizler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 1990'dan beri yayımladığı İnsani Gelişme Endeksi üç boyutu birleştirir: uzun ve sağlıklı yaşam, bilgi ve insana yakışır yaşam standardı. Sunum endeksin bileşenlerinin 2010'da değiştiğini vurgular:

| Boyut | 1990-2010 | 2010'dan itibaren |
|---|---|---|
| Uzun ve sağlıklı yaşam | Doğumda beklenen ortalama ömür | Doğumda beklenen yaşam süresi |
| Bilgi | Yetişkinlerde okuryazarlık oranı | Beklenen okullaşma yılı (ve ortalama okullaşma yılı) |
| Yaşam standardı | Gayri safi yurt içi hasıla (kişi başı) | Kişi başı gayri safi milli gelir |

Değişikliğin nedeni, okuryazarlığın birçok ülkede neredeyse evrensel hâle gelmesi ve ülkeler arasında ayırt edici olmaktan çıkmasıdır. Milli gelir ise yurt içi hasıladan farklı olarak ülke vatandaşlarının yurt dışından elde ettiği geliri de içerir ve yaşam standardını daha iyi yansıtır.

Sağlık eşitsizliği çalışmalarında kullanılacak en kapsamlı veri kaynakları sunuma göre şunlardır: Dünya Sağlık İstatistikleri, sağlıkla ilişkili Bin Yıl Kalkınma Hedefleri göstergeleri, yaşam beklentisi ve mortalite verileri, nedene özel mortalite ve morbidite verileri, sağlık harcamaları, sağlık eşitsizlik göstergeleri ve demografik ve sosyoekonomik istatistikler.

## 5.2. Ülke içi eşitsizlik: nasıl ölçülür?

Ülke içi eşitsizliği ölçmek için bir sağlık göstergesi (örneğin 5 yaş altı ölüm hızı) bir eşitsizlik boyutuna göre (örneğin gelir dilimi) alt gruplara ayrılır ve alt gruplar karşılaştırılır. En basit iki ölçü şunlardır:

- **Mutlak fark:** iki uç grubun değerleri arasındaki fark. Türkiye'de 5 yaş altı ölüm hızı için 27,9 − 8,1 = binde 19,8. Bu sayı, eşitsizliğin halk sağlığı yükünü gösterir: kötü durumdaki gruptaki her 1000 çocuktan yaklaşık 20'si, iyi durumdaki grubun koşullarında yaşasa ölmeyecekti.
- **Göreli fark (oran):** 27,9 / 8,1 ≈ 3,4. Kötü durumdaki grupta bir çocuğun 5 yaşından önce ölme riski 3,4 kat fazladır.

İki ölçü farklı yönlere gidebilir. Ölüm hızları her iki grupta da düştüğünde mutlak fark küçülürken oran artabilir. Örneğin hızlar 40 ve 20'den 12 ve 4'e inerse mutlak fark 20'den 8'e küçülür, oran ise 2'den 3'e çıkar. Bu yüzden eşitsizlik raporlarında ikisi birlikte verilir. Bütün alt grupları birlikte hesaba katan karmaşık ölçüler de vardır (eğim eşitsizlik indeksi, konsantrasyon indeksi), ama mantıkları aynıdır.

***Health Equity Monitor ve HEAT***

DSÖ'nün **Health Equity Monitor Database** (sağlıkta eşitlik gözlem veritabanı) **1991-2019 yılları arasında 115 ülkede 450'den fazla uluslararası hane sağlığı anketinden** (Demografik ve Sağlık Araştırmaları gibi) elde edilen verileri içerir. Bu verileri incelemek için geliştirilen yazılım **Sağlıkta Eşitlik Değerlendirme Araç Seti'dir (Health Equity Assessment Toolkit, HEAT)**. HEAT, üreme, anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı göstergelerini **eşitsizliğin beş boyutuna** göre ayırarak bir ülkedeki eşitsizliklerin değerlendirilmesine olanak tanır:

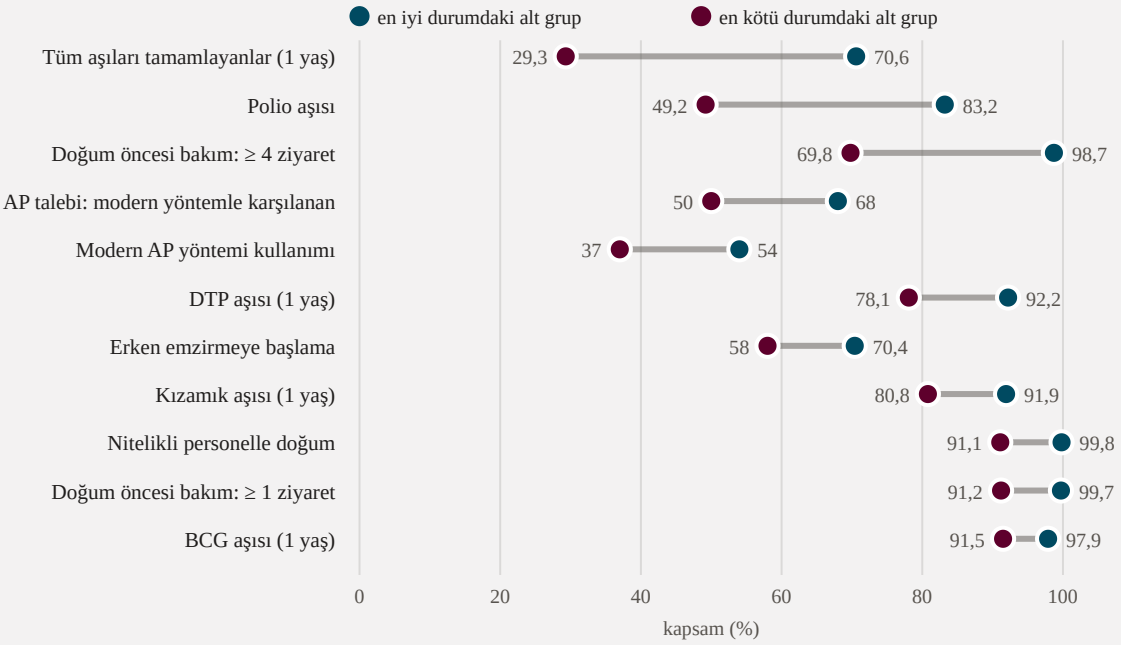
| **HEAT'in beş eşitsizlik boyutu** |
|---|
| 1. Ekonomik durum (hane refah dilimi) · 2. Eğitim (annenin eğitim düzeyi) · 3. İkamet yeri (kentsel ya da kırsal) · 4. Dezavantajlı alanlar (ülke içi bölge) · 5. Çocuğun cinsiyeti |

**HEAT Plus**, kullanıcının kendi yüklediği veri kümeleriyle sağlık eşitsizliklerinin etkileşimli olarak keşfedilmesine ve karşılaştırılmasına olanak tanıyan sürümdür.

## 5.3. Türkiye'de sağlık eşitsizlikleri

Sunum, Health Equity Monitor'ün Türkiye profilinden bir dizi göstergeyi, alt gruplar arasındaki en düşük ve en yüksek değerleriyle verir. Şekil 5.1 hizmet kapsamı göstergelerini, Şekil 5.2 ölüm hızlarını ve beslenme göstergelerini gösterir.

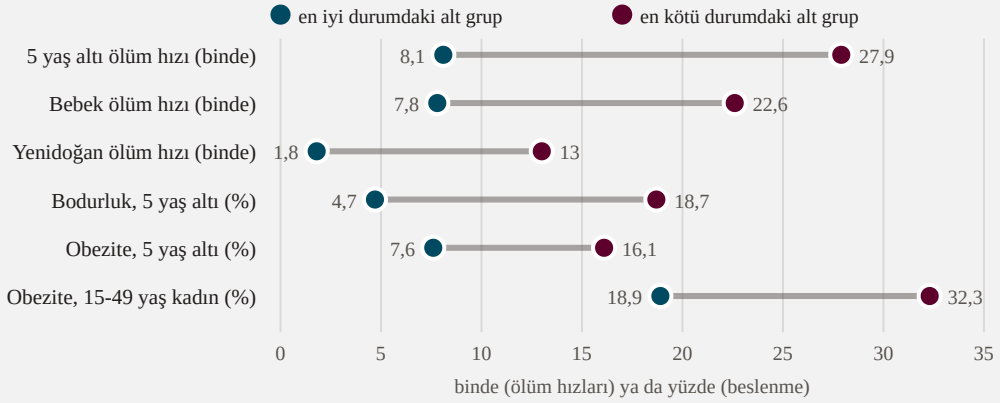
Şekil 5.1'deki örüntü öğreticidir. **Bir kez verilen hizmetlerde** (doğumda yapılan BCG aşısı, en az bir doğum öncesi bakım ziyareti, sağlık kuruluşunda doğum) alt gruplar arasındaki fark %10'un altındadır. Türkiye bu hizmetleri neredeyse herkese ulaştırmıştır. **Süreklilik gerektiren hizmetlerde** ise fark büyür: en az dört doğum öncesi ziyaret %69,8 ile %98,7, bütün aşıların bir yaşından önce tamamlanması %29,3 ile %70,6 arasında değişir. Sürekli hizmet, ailenin sağlık sistemiyle tekrar tekrar temas kurmasını gerektirir ve ulaşım, zaman, bilgi ve iş koşulları gibi engellerin her biri bu zincirde bir kopmaya neden olur. Bu, 2008 raporunun "parçalı hizmet" sorununa ve Astana'nın "hizmetin sürekliliği" vurgusuna somut bir örnektir. Sezaryen oranındaki fark (%29,1 ile %66,9) farklı bir türden eşitsizliktir: bir grupta hizmete erişimin yetersizliğini, diğerinde gereksiz kullanımı yansıtabilir.




Satırlar iki uç arasındaki farka göre sıralanmıştır. Kaynak: sunumdaki DSÖ Health Equity Monitor Türkiye profili.

*Şekil 5.1 — Türkiye'de hizmet kapsamı göstergelerinde alt gruplar arasındaki farklar. Her satırda iki nokta, en kötü ve en iyi durumdaki alt grubun değerlerini gösterir. Çizginin uzunluğu eşitsizliğin büyüklüğüdür. En büyük farklar aşılamanın tamamlanmasında ve doğum öncesi bakımın yeterli sayıda ziyaretle sürdürülmesindedir. Bir kez yapılan hizmetlerde (BCG aşısı, en az bir doğum öncesi ziyaret, nitelikli personelle doğum) fark küçüktür.*

Ölüm hızlarındaki göreli farkın en büyük olduğu gösterge yenidoğan ölüm hızıdır (binde 1,8 ile 13,0; yaklaşık 7 kat). Bölüm 4.2'de anlatıldığı gibi yenidoğan ölümlerini önlemek doğum sırasında ve hemen sonrasında nitelikli bakım gerektirir ve bu bakım sağlık sisteminin en karmaşık halkalarından biridir. Beslenmede iki yönlü bir tablo vardır: bir grupta bodurluk (%18,7), başka grupta obezite (5 yaş altında %16,1, 15-49 yaş kadında %32,3) öne çıkar. Yetersiz ve aşırı beslenmenin aynı ülkede, farklı sosyal gruplarda birlikte görülmesine "malnütrisyonun çifte yükü" denir.




Yüksek değer kötü sonuçtur. Kaynak: sunumdaki DSÖ Health Equity Monitor Türkiye profili.

*Şekil 5.2 — Türkiye'de ölüm hızları ve beslenme göstergelerinde alt gruplar arasındaki farklar (ölüm hızları binde, beslenme göstergeleri yüzde). En kötü durumdaki alt grupta 5 yaş altı ölüm hızı en iyi gruptakinin 3,4 katı, yenidoğan ölüm hızı yaklaşık 7 katıdır. Bodurluk (kronik yetersiz beslenme) dört kat farklıdır.*

## 5.4. Pandemi: eşitsizliğin hızlandırıcısı

COVID-19 pandemisi, eşitsizliklerin bir kriz sırasında nasıl derinleştiğini gösterdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu 2022'ye göre aşılama ve hızlanan dijitalleşme bazı ülkelerin ekonomik krizden hızla kurtulmasını sağladı, ama diğerleri en kötü sonuçlarla mücadele etmeye devam etti. Rapor yazıldığında dünya nüfusunun yarısı hâlâ aşısızdı, %40'ı dijital erişim sağlayamıyordu ve öğrencilerin yalnızca %35'i okulların tamamen açık olduğu ülkelerde yaşıyordu. Sunumdaki diğer veriler:

- 2022 başında 282 milyon doğrulanmış vakadan 5,4 milyon COVID-19 ölümü tespit edilmişti.
- 50 ülke nüfusunun %70'inden fazlasını aşılamıştı. Buna karşılık **dünya nüfusunun %20'sine ev sahipliği yapan en yoksul 52 ülkede aşılanma oranı %6'ydı**.
- Pandemi dünya çapında 53 milyon yeni majör depresyon olgusuna yol açtı.
- Çoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 41 milyon ölüme yol açan bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığı arttı, çünkü kronik hastalıkların izlemi ve tedavisi aksadı.

Aşılanma oranlarındaki fark (%70'in üzeri ile %6) ters bakım yasasının küresel ölçekteki en açık örneklerinden biridir: koruyucu araca en çok ihtiyacı olan, sağlık sistemi en zayıf ülkeler ona en son ulaştı.

## 5.5. Sağlıkta eşitsizliklerle mücadele

DSÖ'nün Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu (2008), eşitsizliklerle mücadeleyi üç ilkeye dayandırır. Sunum bu ilkeleri şöyle verir:

| İlke | Anlamı ve örnekleri |
|---|---|
| **1. Günlük yaşam koşullarını iyileştirin** | İnsanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı koşullar: erken çocukluk gelişimi, sağlıklı konut ve çevre, güvenli iş, sosyal koruma, evrensel sağlık hizmeti (Dahlgren-Whitehead modelinin dördüncü halkası) |
| **2. Güç, para ve kaynakların adaletsiz dağılımıyla mücadele edin** | Günlük koşulları belirleyen yapısal etkenler: hakkaniyete dayalı vergi ve finansman, toplumsal cinsiyet eşitliği, katılımcı yönetim (modelin en dış halkası) |
| **3. Sorunu ölçün ve anlayın ve eylemin etkisini değerlendirin** | Alt gruplara ayrılmış veri toplamak, eşitsizliği izlemek, politikaların etkisini ölçmek, sağlık çalışanlarını sosyal belirleyiciler konusunda eğitmek |

Bu üç ilke, önceki bölümlerdeki bütün parçaları birleştirir. Birinci ve ikinci ilke "nedenlerin nedenleri"ne yöneliktir (Bölüm 2). Üçüncü ilke HEAT gibi ölçüm araçlarının varlık nedenidir (Bölüm 5.2). Evrensel sağlık kapsamı (Bölüm 4.4) ve güçlü bir birinci basamak (Alma-Ata ve Astana, Bölüm 3) ise sağlık sisteminin bu mücadeleye katkısıdır.

### 5.6. Hekime düşen görevler

Alman patolog Rudolf Virchow 1848'de, Silezya'daki tifüs salgınını inceledikten sonra salgının asıl nedeninin yoksulluk olduğu sonucuna vardı ve şunu yazdı: "Tıp bir sosyal bilimdir ve siyaset büyük ölçekte tıptan başka bir şey değildir." Hekim sağlığın sosyal belirleyicilerini tek başına değiştiremez, ama her düzeyde eşitsizliği azaltacak ya da artıracak kararlar verir:

- **Hasta düzeyinde:** öyküye sosyal öyküyü (meslek, konut, ısınma yakıtı, gelir, eğitim, sosyal destek) eklemek. KOAH tanısı konan sigara içmeyen bir kadına evde ne yaktığını sormak. Tedaviyi hastanın koşullarına uydurmak: ödeyemeyeceği bir ilacı yazmak yerine erişebileceği eşdeğerini seçmek, inhaler tekniğini hastanın anlayacağı dilde öğretmek, gerekirse tercüman kullanmak.
- **Toplum düzeyinde:** birinci basamakta risk gruplarını tanımak ve onlara ulaşmak (aşısı eksik çocuklar, dört doğum öncesi ziyareti tamamlamayan gebeler, ev ziyareti gereken yaşlılar). Hizmeti en az kullanan, en çok ihtiyacı olan gruba yönlendirmek: ters bakım yasasına karşı çalışmak.
- **Sistem düzeyinde:** doğru ve eksiksiz kayıt tutmak (eşitsizliği ölçmenin temeli), sektörler arası işbirliğine katılmak (okul, belediye, sosyal hizmetler) ve sağlık politikalarının dezavantajlı gruplar üzerindeki etkisini savunuculuk yoluyla görünür kılmak.

Sunum, DSÖ'nün "Herkes İçin Sağlık" film festivalinden "Bir Doktorun Rüyası" adlı kısa filmlerle sona erer. Filmlerin konusu, bu bölümün de konusudur: hekimin işi yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, hastalığın ortaya çıktığı koşulları da görmektir.

## Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU 1 (YENİ)

**2010'dan itibaren İnsani Gelişme Endeksi'nin hesaplanmasında kullanılan bileşenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?**

A) Bebek ölüm hızı, okuryazarlık oranı, kişi başı GSYİH · B) Doğumda beklenen yaşam süresi, beklenen okullaşma yılı, kişi başı gayri safi milli gelir · C) Doğumda beklenen yaşam süresi, yetişkin okuryazarlık oranı, kişi başı GSYİH · D) Anne ölüm oranı, okullaşma oranı, işsizlik oranı · E) Kaba ölüm hızı, eğitim harcaması, kişi başı sağlık harcaması

**Doğru: B.** 2010'dan itibaren endeks doğumda beklenen yaşam süresini, eğitimi (beklenen ve ortalama okullaşma yılı) ve kişi başı gayri safi milli geliri kullanır.

C, 1990-2010 arasındaki bileşenlerdir: okuryazarlık oranı ve yurt içi hasıla 2010'da değiştirildi. A, D ve E'deki göstergeler endeksin bileşenleri değildir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 2 (YENİ)

### DSÖ'nün Sağlıkta Eşitlik Değerlendirme Araç Seti'nde (HEAT) kullanılan eşitsizlik boyutlarından biri değildir?

A) Ekonomik durum · B) Eğitim · C) İkamet yeri · D) Çocuğun cinsiyeti · E) Kan grubu

**Doğru: E.** HEAT'in beş boyutu ekonomik durum, eğitim, ikamet yeri, dezavantajlı alanlar (ülke içi bölge) ve çocuğun cinsiyetidir. Kan grubu biyolojik bir özelliktir ve sosyal bir eşitsizlik boyutu değildir.

A, B, C ve D, HEAT'in boyutlarıdır.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*

PEKİŞTİRME SORUSU 3 (YENİ)

### DSÖ Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu'nun eşitsizliklerle mücadele için önerdiği üç ilkeden biri değildir?

A) Günlük yaşam koşullarını iyileştirmek · B) Güç, para ve kaynakların adaletsiz dağılımıyla mücadele etmek · C) Sorunu ölçmek, anlamak ve eylemin etkisini değerlendirmek · D) Sağlık hizmetlerini yalnızca hastanelerde yoğunlaştırmak · E) Yukarıdakilerin hepsi komisyonun ilkesidir

**Doğru: D.** Hizmetlerin hastanelerde yoğunlaşması, 2008 DSÖ raporunun "yanlış yönlü hizmet" olarak eleştirdiği durumdur ve güçlü birinci basamak ilkesine ters düşer.

A, B ve C komisyonun üç ilkesidir. E yanlıştır, çünkü D bu ilkelerden biri değildir.

*Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır*